

**COOPERATION AGREEMENT
IN HEALTH SERVICES**

Between

**PT. DISA PRIMA MEDIKA
(PRIMA HUSADA MALANG HOSPITAL AND PRIMA
HUSADA SUKOREJO HOSPITAL)**

With

PT. YANMAR DIESEL INDONESIA

Nomor: (PIHAK 1)

Nomor: (PIHAK 2)

Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan (selanjutnya disebut sebagai “**Perjanjian**”) ini dibuat dan ditandatangani di Sukorejo, pada hari Sabtu tanggal 02 bulan Maret tahun 2024 (Sabtu, dua Maret dua ribu dua puluh empat), oleh dan antara:

I. PT DISA PRIMA MEDIKA, badan hukum yang berdiri dan tunduk berdasarkan dan kepada Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Malang, beralamat di Banjararum Selatan 3 Mondoroko, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh **Endang Susilowati** dalam kedudukannya sebagai Direktur PT Disa Prima Medika, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Disa Prima Medika No. 10 tanggal 16 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Yudo Sigit Riswanto, SH., Notaris di Malang, selaku pengelola rumah sakit sebagai berikut:

- a. Rumah Sakit Prima Husada Malang, dengan Izin Operasional Rumah Sakit No 81201150810001 tertanggal 17 mai 2022 beralamat di Banjarum Selatan 3 Mondoroko, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- b. Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo, dengan Izin Operasional Rumah Sakit No 81201150815810004 tertanggal 20 sept 2023 beralamat di Jl. Raya Surabaya – Malang KM 54 Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan.
dan untuk selanjutnya disebut “Pihak Kedua”

II. PT ..., berkedudukan di ..., dalam hal ini diwakili oleh ... dalam jabatannya selaku ... dan oleh karenanya sah serta berwenang bertindak untuk dan atas nama (untuk selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”).

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (secara bersama-sama disebut “**Para Pihak**” dan masing-masing sebagai “**Pihak**”) terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

**PERJANJIAN KERJASAMA
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN**

Antara

**PT. DISA PRIMA MEDIKA
(RS PRIMA HUSADA MALANG DAN
RS PRIMA HUSADA SUKOREJO)**

Dengan

PT. YANMAR DIESEL INDONESIA

Nomor: (PIHAK 1)

Nomor: (PIHAK 2)

This Health Services Cooperation Agreement (hereinafter referred to as the "Agreement") is made and signed in Sukorejo, on **Saturday, March 02 2024 (second March two thousand and Twenty Four)**, by and between:

I. PT DISA PRIMA MEDIKA, an existing legal body which is subject to the law of the Republic of Indonesia, domiciled in Malang Regency and located in Banjararum Selatan 3 Mondoroko, Singosari District, Malang Regency, in which is represented by Endang Susilowati in her position as Director of PT Disa Prima Medika, according to the Deed of Minutes of the Limited Liability Company Meeting of PT Disa Prima Medika No. 10 on October 2018 made in front of Yudo Sigit Riswanto, SH., notary in Malang, as the hospital manager as follows :

- a. Prima Husada Hospital Malang, with the Hospital Operational Permit No No 81201150810001 dated Mai 17 th 2022 having its address at Banjarum Selatan 3 Mondoroko, Singosari District, Malang Regency
- b. Prima Husada Sukorejo Hospital, with the Hospital Operational Permit No 81201150815810004 dated Sep 20 th 2023 having its address at Jl. Raya Surabaya – Malang KM 54 Lemahbang Village, Sukorejo District, Pasuruan Regency.

(hereinafter referred to as "**THE FIRST PARTY**")

II. PT. YAMINDO, domiciled at ..., in this case represented by ... in his position as ..., from the ... and therefore legally and authorized to act for and on behalf of

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah pengelola **Rumah Sakit Prima Husada Malang dan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo** dengan segala sarana, sumber daya manusia, serta manajemen yang memenuhi persyaratan sebagai rumah sakit dan klinik.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA membutuhkan jasa pelayanan PIHAK PERTAMA dalam hal pelayanan kesehatan bagi karyawan PIHAK KEDUA di rumah sakit milik PIHAK PERTAMA.
- c. Bahwa Para Pihak bermaksud untuk terikat dalam Perjanjian ini dimana PIHAK PERTAMA setuju untuk memberikan jasa pelayanan kesehatan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA setuju menggunakan jasa PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 ISTILAH DAN PENGERTIAN

1. Tertanggung atau Pasien adalah peserta yang terdaftar secara administrasi sebagai peserta di PIHAK KEDUA dan/atau anggota keluarganya yang menurut ketentuan Perjanjian Kerja Bersama PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dan pengobatan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.
2. Pelayanan Kesehatan adalah semua pelayanan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
3. Biaya Layanan Kesehatan Adalah selisih biaya yang timbul dari jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada Pasien PIHAK KEDUA yang terdiri dari jasa medis, penunjang medis, obat – obatan maupun akomodasi perawatan seperti alat – alat kesehatan lainnya yang diperlukan untuk tindakan pengobatan.
4. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, selanjutnya disingkat FKTP adalah Poliklinik yang telah terdaftar/ bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
5. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang meliputi klinik utama atau yang setara, rumah sakit umum, dan rumah sakit khusus.
6. Peserta adalah Karyawan PIHAK KEDUA beserta anggota keluarganya yang memenuhi syarat untuk memperoleh fasilitas Kesehatan.
7. Peserta CoB adalah Karyawan PIHAK KEDUA beserta anggota keluarganya yang memiliki Surat Jaminan Pembayaran yang digunakan saat mendapatkan pelayanan kesehatan, Tanda Pengenal

(hereinafter referred to as "**THE SECOND PARTY**").

The FIRST PARTY and the SECOND PARTY (collectively the "**Parties**" and each a "**Party**") first explain the following:

- a. Whereas the FIRST PARTY is the manager of **Prima Husada Malang and Prima Husada Sukorejo Hospital** with all the facilities, human resources, and management that meet the requirements as hospitals and clinics.
- b. That the SECOND PARTY requires the services of the FIRST PARTY in terms of health services for the SECOND PARTY's employees at the FIRST PARTY's hospital.
- c. That the Parties intend to be bound by this Agreement where the FIRST PARTY agrees to provide health services to the SECOND PARTY, and the SECOND PARTY agrees to use the FIRST PARTY's services.

Based on the foregoing, the Parties agree to conclude and implement the Agreement in accordance with the following terms and conditions:

ARTICLE 1 TERMS AND UNDERSTANDING

1. The Insured or Patient is a participant who is administratively registered as a participant in the SECOND PARTY and/or his family members who according to the provisions of the SECOND PARTY Collective Labor Agreement have the right to obtain health care and treatment services provided by the FIRST PARTY.
2. Health Services are all services provided by the FIRST PARTY as described in Article 2 of this Agreement.
3. Health Service Costs Is the difference in costs arising from health services provided by the FIRST PARTY to the SECOND PARTY's patients consisting of medical services, medical support, drugs and treatment accommodation such as other medical equipment needed for medical treatment.
4. First Level Health Facility, hereinafter abbreviated as FKTP, is a Polyclinic that has been registered/in collaboration with BPJS Kesehatan.
5. Advanced Level Referral Health Facilities hereinafter abbreviated as FKRTL are health facilities that include main clinics or its equivalent, general hospitals, and special hospitals.
6. Participants are employees of the SECOND PARTY and their family members who meet the requirements to obtain Health facilities.
7. CoB participants are employees of the SECOND PARTY and their family members who have a

-
- Karyawan dan atau Buku Berobat Karyawan dan Buku Berobat Keluarga Karyawan.
8. Formularium Nasional adalah daftar obat yang disusun oleh komite nasional yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, didasarkan pada bukti ilmiah mutakhir berkhasiat, aman, dan dengan harga yang terjangkau yang disediakan serta digunakan sebagai acuan penggunaan obat dalam jaminan kesehatan nasional.
 9. Formularium Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo adalah suatu daftar sediaan obat yang telah diproses melalui evaluasi dan seleksi oleh staf medis dan penunjang medis, melalui Komite Farmasi dan Terapi yang dianggap paling bermanfaat dalam perawatan pasien dan oleh karena itu secara rutin disediakan oleh Instalasi Farmasi.
 10. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap adalah semua pelayanan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam upaya pemulihan kesehatan Tertanggung berupa:
 - a. Rawat Inap yaitu perawatan di rumah sakit yang dibuktikan dengan adanya tagihan biaya kamar perawatan dengan atau tanpa tindakan operasi;
 - b. Gawat Darurat adalah suatu keadaan yang memerlukan pelayanan medis segera dan tidak boleh ditunda dalam waktu dua belas (12) jam yang diperlukan untuk menyelamatkan jiwa atau mencegah terjadinya cacat tubuh atau cacat fungsi yang tetap; dan
 11. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan adalah semua layanan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam upaya pemulihan kesehatan Tertanggung, termasuk didalamnya layanan medis, layanan pemakaian prasarana dan sarana kesehatan serta penunjang lainnya bagi Tertanggung yang pemberian pelayanan kesehatannya dilakukan di rumah sakit dan atau unit penunjang lainnya yang tidak memerlukan Rawat Inap.
 12. Kegawat daruratan adalah keadaan darurat yang memerlukan pemeriksaan dan tindakan medis segera yang apabila tidak dilakukan akan menyebabkan hal yang fatal bagi Tertanggung.
 13. Medical Check Up adalah pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, yang bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan, mengantisipasi gangguan kesehatan yang dapat berkembang menjadi penyakit dan penanganan segera jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya suatu kondisi khusus atau penyakit dan gangguan terkait kondisi fisik seseorang yang bisa dilakukan pada sebelum tenaga kerja diterima kerja, pemeriksaan berkala untuk karyawan minimal satu tahun sekali dan pemeriksaan kesehatan khusus.
 14. Surat jaminan adalah surat yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA yang dipergunakan sebagai alat bukti guna melaksanakan Pelayanan Kesehatan oleh PIHAK PERTAMA kepada Tertanggung PIHAK KEDUA sesuai isi Surat Jaminan tersebut.
- Payment Guarantee Letter which is used when obtaining health services, Employee Identification Card and or Employee Medical Book and Employee Family Medicine Book.
8. National Formulary is a list of drugs compiled by a national committee determined by the Minister of Health, based on the latest scientific evidence that is efficacious, safe, and at an affordable price which is provided and used as a reference for the use of drugs in national health insurance.
 9. Prima Husada Sukorejo Hospital Formulary is a list of medicinal preparations that have been processed through evaluation and selection by medical and medical support staff, through the Pharmacy and Therapeutic Committee which are considered the most useful in patient care and are therefore routinely provided by the Pharmacy Installation..
 10. Inpatient Health Services are all services provided by the FIRST PARTY in an effort to restore the Insured's health in the form of:
 - a. Inpatient care is treatment in a hospital as evidenced by the existence of a bill for the treatment room with or without surgery;
 - b. Emergency is a condition that requires immediate medical services and should not be delayed within the twelve (12) hours needed to save lives or prevent permanent physical or functional disabilities from occurring; and
 11. Outpatient Health Services are all services provided by the FIRST PARTY in an effort to restore the Insured's health, including medical services, services for the use of health infrastructure and facilities as well as other supports for the Insured whose health services are provided in hospitals and or other supporting units that do not require Inpatient.
 12. An emergency is an emergency that requires immediate medical examination and action which if not carried out will cause fatal things to the Insured.
 13. Medical Check Up is a comprehensive health examination, which aims to ensure health conditions, anticipate health problems that can develop into disease and treat immediately if the results of the examination indicate the presence of a special condition or disease and disorder related to a person's physical condition. What can be done before workers are accepted for work, periodic checks for employees at least once a year and special health checks.
 14. Guarantee letter is a letter issued by the SECOND PARTY which is used as evidence to carry out Health Services by the FIRST PARTY

15. Ekses Klaim Adalah selisih biaya yang timbul akibat perawatan di RS yang tidak dijamin oleh Asuransi Kesehatan yang harus dibayar oleh perusahaan.

PASAL 2

LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

PIHAK PERTAMA memberikan pelayanan kesehatan kepada Tertanggung dari PIHAK KEDUA mencakup :

1. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap dan pelayanan pendukungnya seperti : Pelayanan pengobatan dan penggunaan peralatan kedokteran, obat, perawatan penggunaan kamar bedah, pemeriksaan laboratorium dan lain-lain yang diperlukan untuk pengobatan penyembuhan.
2. Kegawat Daruratan seperti : Kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas dan penyakit kronis.
3. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan meliputi pemeriksaan dokter umum, dokter spesialis, obat, pemeriksaan laboratorium dan lain-lain yang diperlukan untuk penyembuhan.
4. Medical Check Up dengan layanan pemeriksaan di perusahaan dengan peserta minimal 50 peserta.

PASAL 3

PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN COB

1. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL)
 - a. Merupakan tindak lanjut dari Unit Gawat Darurat, dan klinik Rawat Jalan Tingkat Lanjutan.
 - b. PIHAK PERTAMA menerima peserta yang dilengkapi dengan Surat Jaminan Pembayaran dan E-Id Kartu asuransi kesehatan yang sudah bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA / Tanda Pengenal Karyawan / Buku Berobat Karyawan atau Buku Berobat Keluarga dari Pasien ataupun PIHAK KEDUA. Contoh tanda pengenal peserta dapat dilihat di Lampiran 1 dan surat jaminan pembayaran di Lampiran 2
 - c. Peserta atau PIHAK KEDUA harus melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud point b diatas maksimal 3X24 jam pada hari kerja sejak masuk Rawat Inap di fasilitas kesehatan PIHAK PERTAMA.
 - d. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan keabsahan Surat jaminan Pembayaran dan E-Id Asuransi Kesehatan, kemudian melakukan entry data ke dalam aplikasi Surat Eligibilitas Peserta (SEP) untuk memeriksa status kepesertaan.
 - e. Apabila peserta dalam kurun waktu 3x24 jam tidak dapat memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi Rawat Inap sebagai pasien CoB Asuransi Kesehatan BPJS Kesehatan atau Surat

to the SECOND PARTY Insured according to the contents of the Guarantee Letter.

15. Excess Claim Is the difference in costs incurred as a result of hospitalization that is not covered by Health Insurance that must be paid by the company.

ARTICLE 2

SCOPE OF HEALTH SERVICES

The FIRST PARTY provides health services to the Insured from the SECOND PARTY including:

1. Inpatient Health Services and supporting services such as treatment and use of medical equipment, drugs, treatment, use of operating rooms, laboratory examinations and others needed for healing treatment.
2. Emergencies such as work accidents, traffic accidents and chronic diseases.
3. Outpatient Health Services include examinations of general practitioners, specialists, drugs, laboratory examinations and others needed for healing.
4. Medical Check Up with an examination service at a company with a minimum of 50 participants.

ARTICLE 3

COB HEALTH SERVICE PROCEDURE

1. Advanced Hospitalization (RITL)
 - a. It is a follow-up from the Emergency Unit, and the Advanced Outpatient clinic.
 - b. The FIRST PARTY accepts participants who are equipped with a Payment Guarantee Letter and an E-Id Health insurance card that has collaborated with the FIRST PARTY / Employee ID / Employee Medical Book or Family Medicine Book from the patient or the SECOND PARTY.
 - c. The Participant or the SECOND PARTY must complete the administrative requirements as referred to in point b above a maximum of 3X24 hours on working days from the time of admission to the hospitalization at the FIRST PARTY health facility.
 - d. The FIRST PARTY is responsible for checking the validity of the Payment Guarantee Letter and Health Insurance E-Id, then doing data entry into the Participant Eligibility Letter (SEP) application to check the membership status.
 - e. If the participant within 3x24 hours is unable to fulfill the completeness of the Inpatient administration requirements as a Health

Jaminan dari perusahaan, maka diberlakukan sebagai pasien umum, maka akibat dan kewajiban yang timbul seluruhnya menjadi tanggung jawab Peserta.

- f. Peserta akan ditempatkan pada kelas perawatan sesuai dengan hak kelas pasien CoB yang tercantum dalam Surat Jaminan / sesuai kelas BPJS Kesehatan dan tagihan kepada PIHAK KEDUA adalah selisih tarif kesepakatan sesuai dengan kelas perawatan yang ditempati dikurangi hak rawat tarif dari Asuransi Kesehatan.
- g. Tertanggung yang memerlukan perawatan Rumah Sakit akan ditempatkan di kamar sesuai dengan kelasnya atau di kamar yang biaya sewanya tidak melampaui jumlah maksimum tunjangan kamar dan ruang yang tertera dalam BPJS Kesehatan.
- h. Dalam keadaan kelas perawatan yang menjadi hak kelas peserta tidak tersedia atau penuh yang dibuktikan dengan surat keterangan dari PIHAK PERTAMA, maka peserta ditempatkan 1 kelas lebih tinggi dari hak rawatnya, dalam waktu maksimal 3 x 24 jam PIHAK PERTAMA akan menempatkan peserta pada kelas yang menjadi haknya dan selisih biaya yang timbul akibat kenaikan kelas menjadi tanggungan PIHAK KEDUA. Dan apabila melebihi 3x24 jam maka biaya yang timbul akibat kenaikan kelas menjadi tanggungan PIHAK KEDUA (tarif kesepakatan kelas perawatan yang ditempati dikurangi hak rawat tarif Asuransi Kesehatan).
- i. Apabila Peserta memerlukan jenis pemeriksaan yang tidak tersedia pada fasilitas kesehatan yang dikelola PIHAK PERTAMA maka dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan lain atas persetujuan PIHAK KEDUA.
- j. Setelah dilakukan verifikasi oleh PIHAK PERTAMA maka akan dilakukan rekonsiliasi dan PIHAK PERTAMA akan menagihkan selisih tersebut kepada PIHAK KEDUA

2. Pelayanan Gawat Darurat

Dalam keadaan gawat darurat, maka:

- a. Dalam keadaan gawat darurat pelayanan harus segera diberikan tanpa menunggu surat rujukan dari PIHAK KEDUA. Peserta dapat langsung datang ke Rumah Sakit yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA melalui Unit Gawat Darurat (UGD).
- b. PIHAK PERTAMA akan melakukan pengecekan validitas Tanda Pengenal Karyawan / Buku Berobat Karyawan / Buku Berobat Keluarga Karyawan yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA dan Kartu Peserta BPJS Kesehatan. Contoh tanda pengenal karyawan dapat dilihat di Lampiran 1.
- c. PIHAK PERTAMA hanya menerima seorang Tertanggung yang memperlihatkan Surat Jaminan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang PIHAK

Insurance CoB patient, he will be treated as a general patient. then the consequences and obligations that arise are entirely the responsibility of the Participant.

- f. Participants will be placed in the treatment class according to the class rights of the CoB patients listed in the Payment Guarantee Letter and the invoice to the SECOND PARTY is the difference in the agreed rate according to the class of care occupied minus the right of care rates from Health Insurance.
- g. The insured who requires hospital treatment will be placed in a room according to his class or in a room whose rental fee does not exceed the maximum number of room and space allowances stated in BPJS Kesehatan.
- h. In the event that the treatment class to which the participant's class is entitled is not available or full as evidenced by a certificate from the FIRST PARTY, the participant is placed 1 class higher than his/her right to care, within a maximum of 3 x 24 hours the FIRST PARTY will place the participant in the class to which he/she is entitled. and the difference in costs arising from the increase in class will be borne by the SECOND PARTY. And if it exceeds 3x24 hours, the costs incurred due to the increase in class will be borne by the SECOND PARTY (the agreed treatment class rate is reduced by the right to care for the Health Insurance rate),
- i. If the Participant requires a type of examination that is not available at a health facility managed by the FIRST PARTY, a referral will be made to another health facility with the approval of the SECOND PARTY.
- j. After verification by the BPJS, a reconciliation will be carried out and the FIRST PARTY will charge the difference to the SECOND PARTY.

2. Emergency Services

In an emergency, then:

- a. In an emergency situation, services must be provided immediately without waiting for a referral letter from the SECOND PARTY. Participants can come directly to the Hospital managed by the FIRST PARTY through the Emergency Unit (ER).
- b. The FIRST PARTY will check the validity of the Employee ID / Employee Medical Book / Employee Family Medicine Book issued by the SECOND PARTY and BPJS Health Participant Card.
- c. The FIRST PARTY only accepts an Insured who shows a Guarantee Letter signed by the SECOND PARTY authorized official. In an

KEDUA. Dalam keadaan gawat darurat, sakit secara tiba-tiba atau kecelakaan atau hari libur resmi Surat Jaminan tidak diperlukan agar Tertanggung dari PIHAK KEDUA memperoleh pelayanan pengobatan, namun surat tersebut harus diserahkan selambat-lambatnya dalam tempo **3x24** jam berikutnya.

- d. Tertanggung yang memerlukan perawatan Rumah Sakit akan ditempatkan di kamar perawatan sesuai dengan hak kelasnya. Jika kategori kamar yang menjadi hak Tertanggung penuh, ia akan ditempatkan di kamar lain yang biaya kelasnya lebih besar/lebih kecil dari jumlah maksimum tunjangan kamar dan ruang yang tertera dalam Surat Jaminan.
- e. Jika kamar yang digunakan sementara melebihi jumlah maksimum tunjangan kamar seperti yang tertera dalam Surat Jaminan, maka PIHAK KEDUA akan membayar biaya tambahan selama diruang sementara.

3. Pelayanan Rawat Jalan

- a. Pelayanan dapat digunakan dengan menunjukkan Kartu Pengenal Karyawan / Buku Berobat yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA. Contoh tanda pengenal peserta dapat dilihat di Lampiran 1.
- b. Adapun jenis pelayanan rawat jalan yang tidak dapat ditanggung oleh PIHAK KEDUA adalah :
- Penyakit yang terjadi pada pasien dan bertambah parah oleh karena kesalahan atau kelalaian pasien sendiri, tidak mengindahkan ajuran dokter
 - Perawatan yang dilakukan tanpa rujukan / perintah dari dokter
 - Pasien menderita penyakit kelamin atau penyakit akibat penggunaan obat terlarang.
 - Pemeriksaan kesehatan, pengobatan atau perawatan yang berhubungan dengan kosmetika/kecantikan dan atau memperindah tubuh. (Perawatan dan pengobatan yang berhubungan dengan tujuan estetika termasuk operasi plastik atau bedah/perawatan kosmetik, perawatan khusus untuk pengurangan atau penambahan berat badan dan peningkatan tinggi badan, tindakan orthodontic.)
 - Pemberian obat kuasi/obat bebas dan pengobatan yang tidak ada kaitannya secara langsung atas penyembuhan penyakit yang diderita oleh pasien.
 - Pemeriksaan, pengobatan dan / atau perawatan yang dilakukan oleh karena kesalahan pasien sendiri, misalnya percobaan bunuh diri atau hal lain yang dapat dikategorikan sama dengan hal itu.
 - Biaya pemeriksaan dengan dalih kehamilan atau mengandung, kecuali bila ada kelainan selama masa kehamilannya tersebut dengan dikuatkan oleh Surat Keterangan Dokter Spesialis.

emergency situation, sudden illness or accident or an official holiday, a Guarantee Letter is not required so that the Insured from the SECOND PARTY can receive medical treatment, but the letter must be submitted no later than the next **3x24** hours.

- d. The insured who requires hospital treatment will be placed in a treatment room according to his class rights. If the room category to which the Insured is fully entitled, he or she will be placed in another room whose class fee is greater/less than the maximum number of room and space allowances stated in the Guarantee Letter.
- e. If the room used temporarily exceeds the maximum number of room allowances as stated in the Letter of Guarantee, then the SECOND PARTY will pay an additional fee while in the temporary room.

3. Outpatient Service

- a. The service can be used by showing the Employee Identification Card / Medical Book issued by the SECOND PARTY
- b. The types of outpatient services that cannot be covered by the SECOND PARTY are:
- Diseases that occur in patients and get worse because of the patient's own mistakes or negligence, do not heed the doctor's advice.
 - Treatments carried out without a referral/order from a doctor.
 - The patient suffers from a venereal disease or disease due to the use of illegal drugs.
 - Health examination, treatment or care related to cosmetics/beauty and or beautifying the body. (Treatments and remedies related to aesthetic purposes including plastic surgery or cosmetic surgery/treatment, special treatments for weight loss or gain and height gain, orthodontic procedures.)
 - Provision of quasi-drugs / over-the-counter drugs and medications that are not directly related to the healing of the disease suffered by the patient.
 - Examination, treatment and / or care carried out by the patient's own fault, for example attempted suicide or other things that can be categorized as similar.
 - Cost of examination on the pretext of pregnancy or pregnancy, unless there are abnormalities during the period of pregnancy confirmed by a Specialist Doctor's Certificate.
 - Pap Smear at the patient's own request without being supported by a medical statement from a specialist doctor.
 - The installation of dentures includes the installation of metal on the teeth, as well as

- Papsmear atas permintaan pasien sendiri tanpa didukung oleh keterangan medis dari Dokter Spesialis
- Pemasangan gigi palsu termasuk pemasangan logam di gigi, maupun prothesa (pengganti gigi yang hilang akibat proses pencabutan atau trauma) dan orthesa atau lainnya yang disamakan dengan itu.
- Pemasangan kawat gigi, pembersihan karang gigi
- Kontrasepsi pil, suntik KB
- Produk yang dibeli secara bebas, atau tidak diperlukan secara medis termasuk : sabun mandi, tissue, pembalut, bedak, obat kumur, pasta gigi, sikat gigi, obat gosok (balsem, minyak angin), susu (terkecuali susu low lactosa untuk anak penderita diare yang di rawat inap), makanan bayi, tagihan telepon dan fax, laundry, obat-obatan yang dibeli diluar apotik serta vitamin dan food supplement yang secara medis tidak diperlukan dan tidak berhubungan dengan penyakitnya.

4. Pelayanan Medical Check Up

- a. Pelayanan bisa dilakukan atas permintaan dari kebutuhan dari perusahaan
- b. Pelayanan dapat digunakan dengan menunjukkan Kartu Pengenal Karyawan / Buku Berobat yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA
- c. Pelayanan bisa dilakukan di perusahaan dengan minimal peserta > 50 orang
- d. Adapun jenis pelayanan medical check up meliputi pemeriksaan
- e. Darah lengkap, Urine lengkap, Faal Hati, SGPT, Faal Ginjal, Urea, Uric Aid, Gula, Lemak, Kholesterol, Jantung, Thorax, Audiometri dll

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berhak menolak penggunaan Surat Jaminan pada keadaan-keadaan di bawah ini:
 - a. Tanda tangan yang berwenang dari PIHAK KEDUA pada Surat Jaminan tidak sesuai dengan contoh tanda tangan yang diberikan di muka kepada PIHAK PERTAMA.
 - b. PIHAK PERTAMA diberitahukan bahwa Tertanggung mengundurkan diri, dipecat atau tidak lagi menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA harus memastikan formulir klaim PIHAK KEDUA sudah dilengkapi sebagaimana mestinya dan jelas oleh setiap Tertanggung dan dokter yang merawat.
3. PIHAK PERTAMA harus menyerahkan kepada PIHAK KEDUA faktur bulanan yang berisikan daftar rincian semua biaya pelayanan perawatan kesehatan dan pengobatan yang telah diberikan kepada para tertanggung selama bulan tersebut.

prostheses (replacements for teeth lost due to the extraction or trauma process) and orthoses or other equivalents.

- Installation of braces, cleaning tartar.
- Contraceptive pills, birth control injections.
- Products that are purchased over-the-counter, or are not medically needed include: bath soap, tissue, sanitary napkins, powder, mouthwash, toothpaste, toothbrush, liniment (balm, wind oil), milk (except low-lactose milk for children with diarrhea). hospitalized), baby food, telephone and fax bills, laundry, medicines purchased outside the pharmacy as well as vitamins and food supplements which are not medically necessary and not related to the disease.

4. Medical Check Up Service

- a. Services can be done upon request from the needs of the company.
- b. The service can be used by showing the Employee Identification Card / Medical Book issued by the SECOND PARTY.
- c. Services can be carried out in companies with a minimum of 50 participants.
- d. The types of medical check-up services include examinations: complete blood, complete urine, liver function, SGPT, kidney function, urea, uric acid, sugar, fat, cholesterol, heart, thorax, audiometry, etc.

ARTICLE 4

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE FIRST PARTY

1. The FIRST PARTY has the right to refuse the use of the Letter of Guarantee in the following circumstances:
 - a. The authorized signature of the SECOND PARTY on the Guarantee Letter does not match the sample signature given in advance to the FIRST PARTY.
 - b. The FIRST PARTY is notified that the Insured resigns, is fired or is no longer the responsibility of the SECOND PARTY.
2. The FIRST PARTY must ensure that the SECOND PARTY claim form has been properly and clearly completed by each Insured and the treating doctor.
3. The FIRST PARTY must submit to the SECOND PARTY a monthly invoice containing a detailed list of all costs of health care and medical services that have been provided to the insured during the month.

4. PIHAK PERTAMA harus melakukan kerjasama dengan pihak Asuransi Kesehatan, sehingga dapat memberikan Pelayanan Kesehatan Pasien PIHAK KEDUA dengan sistem CoB.
5. PIHAK PERTAMA harus melakukan prosedur CoB sebagai prioritas utama dalam melayani perawatan kesehatan dan pengobatan pasien dari PIHAK KEDUA
6. PIHAK PERTAMA berkewajiban mengkonfirmasi segala tindakan medis dengan biaya di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Bagian HRD & GA sebagaimana tercantum pada Alamat Korespondensi PIHAK KEDUA, kecuali dalam keadaan darurat.
7. PIHAK PERTAMA berhak memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA jika terdapat karyawan PIHAK KEDUA yang akan menggunakan fasilitas PIHAK PERTAMA.
8. PIHAK PERTAMA menyediakan pelayanan Unit Gawat Darurat bagi PIHAK KEDUA, selama 24 (dua puluh empat) jam per hari termasuk fasilitas instalasi farmasi / apotek, laboratorium, dan radiologi.
9. PIHAK PERTAMA wajib menginformasikan secara tertulis dan detail alasan kepada PIHAK KEDUA bilamana pasien PIHAK KEDUA tidak dapat diiberlakukan sistem CoB.
10. PIHAK PERTAMA akan memperlakukan Pasien seperti pasien biasa, apabila:
 - a. Pasien tidak dapat memperlihatkan Tanda Bukti Diri (ID Card), kecuali dalam keadaan darurat.
 - b. Pihak yang datang untuk berobat di Rumah Sakit atau klinik yang dikelola PIHAK PERTAMA tidak terdaftar dalam daftar nama Pasien yang dikirimkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Pasien berhak mendapat fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tersedia dari PIHAK PERTAMA setiap saat dibutuhkan.
2. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA contoh tanda tangan para pejabat yang berwenang untuk menandatangani Surat Jaminan.

PASAL 6 MUTU

Demi menjaga kualitas mutu PARA PIHAK :

1. PIHAK KEDUA harus tepat memenuhi pembayaran atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 Perjanjian ini.
2. PIHAK KEDUA harus memberikan kelengkapan data administrasi dengan cepat untuk menunjang PIHAK PERTAMA dalam melakukan penagihan.

4. The FIRST PARTY must cooperate with the Health Insurance, so that it can provide the SECOND PARTY Patient Health Services with the CoB system.
5. The FIRST PARTY must carry out CoB procedures as a top priority in serving the health care and treatment of patients from the SECOND PARTY.
6. The FIRST PARTY is obliged to confirm all medical procedures with a cost of more than Rp. 5,000,000.00 (five million rupiah) to the HRD & GA Section as stated in the Correspondence Address of the SECOND PARTY, except in an emergency.
7. The FIRST PARTY has the right to provide information to the SECOND PARTY if there are SECOND PARTY employees who will use the FIRST PARTY facilities.
8. The FIRST PARTY provides Emergency Unit services for the SECOND PARTY, for 24 (twenty four) hours per day including pharmacy / pharmacy, laboratory, and radiology installation facilities.
9. The FIRST PARTY is obliged to inform in writing and detail the reasons to the SECOND PARTY if the SECOND PARTY's patient cannot apply the CoB system.
10. The FIRST PARTY will treat the patient like an ordinary patient, if:
 - a. Patients cannot show ID Card, except in an emergency.
 - b. The party who comes for treatment at the Hospital or clinic managed by the FIRST PARTY is not registered in the list of patient names sent by the SECOND PARTY to the FIRST PARTY.

ARTICLE 5 RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE SECOND PARTY

1. Patients have the right to health service facilities available from the FIRST PARTY at any time needed.
2. The SECOND PARTY shall submit to the FIRST PARTY sample signatures of the officials authorized to sign the Guarantee Letter.

ARTICLE 6 QUALITY

In order to maintain the quality of the PARTIES:

1. The SECOND PARTY must properly fulfill the payment for health services that have been provided by the FIRST PARTY as described in Article 7 of this Agreement.
2. The SECOND PARTY must provide complete administrative data quickly to support the FIRST PARTY in billing.

PASAL 7
TATA CARA PEMBAYARAN

1. Biaya Pelayanan Kesehatan untuk Rawat Inap menjadi tanggungan PIHAK KEDUA, jika dalam hal pembayaran Asuransi Kesehatan lebih kecil dari biaya layanan kesehatan yang diberikan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban membayar selisih tagihan atas biaya layanan kesehatan tersebut.
2. Penagihan atas biaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal Perjanjian ini, akan dilakukan PIHAK PERTAMA segera setelah pelayanan kesehatan selesai diberikan.
3. Penagihan/invoice sekurang-kurangnya memuat dokumen kuitansi yang dilengkapi dengan data perincian biaya perawatan dan dilampirkan Surat Jaminan (asli) serta resume medis / diagnosa, diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam 1 (satu) rangkap dan masing-masing bermeterai cukup.
4. PIHAK KEDUA berhak untuk meneliti kebenaran Dokumen Tagihan yang diberikan PIHAK PERTAMA dan mencocokkannya dengan data internal PIHAK KEDUA.
5. PIHAK KEDUA akan memproses tagihan PIHAK PERTAMA dan melakukan pembayaran setelah tagihan dinyatakan benar dan diterima oleh bagian keuangan PIHAK KEDUA.
6. Pelunasan terhadap Dokumen Tagihan tersebut akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender, setelah Dokumen Tagihan diterima secara lengkap dan benar oleh PIHAK KEDUA dan dibayarkan melalui transfer ke:

RS PRIMA HUSADA MALANG

Nama Penerima	: PT DISA PRIMA MEDIKA
Nama Bank	: PT Bank Central Asia Tbk
Cabang, Alamat Bank	: KK Malang Singosari, Jl Raya Singosari No. 93, Lsari Kec. Singosari, Malang, Jawa Timur 65153
Nomor Rekening	: 368-3040700
Kode Swift / IBAN	: CENAIIDJA

RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

Nama Penerima	: PT DISA PRIMA MEDIKA
Nama Bank	: PT Bank Mandiri Persero Tbk
Cabang, Alamat Bank	: KK Malang Sutoyo, Jl. Letjen Sutoyo No. 18-20, Bunulrejo, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 35141
Nomor Rekening	: 144-0055533324
Kode Swift / IBAN	: BMRIIDJA

7. Apabila diperlukan tindakan/pemeriksaan bagi Pasien di luar Rumah Sakit, atas rekomendasi tertulis PIHAK PERTAMA dan dengan persetujuan tertulis PIHAK KEDUA, maka tagihan akan dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

ARTICLE 7
PROCEDURE OF PAYMENT

1. The cost of Health Services for Inpatient shall be borne by the SECOND PARTY, if in the event that the payment of Health Insurance is less than the cost of health services provided by the FIRST PARTY, then the SECOND PARTY is obliged to pay the difference in the bill for the cost of the health services.
2. Billing for the cost of Health Services as referred to in paragraph (1) of this Agreement. will be carried out by the FIRST PARTY as soon as the health services are provided.
3. The billing/invoice shall at least contain a receipt document which is accompanied by detailed data on treatment costs and attached with a Guarantee Letter (original) as well as a medical/diagnostic resume, submitted by the FIRST PARTY to the SECOND PARTY in 1 (one) copy and each with sufficient stamp duty.
4. The SECOND PARTY has the right to examine the accuracy of the Billing Documents provided by the FIRST PARTY and match it with the SECOND PARTY's internal data.
5. The SECOND PARTY will process the FIRST PARTY's invoice and make payment after the bill is declared correct and accepted by the SECOND PARTY finance department.
6. The settlement of the Billing Documents will be carried out by the SECOND PARTY no later than 30 (thirty) calendar days, after the Billing Documents are received completely and correctly by the SECOND PARTY and paid by transfer to

Prima Husada Malang Hospital

On behalf : PT Disa Prima Medika
of
Bank : PT Bank Central Asia Tbk
Branch : KK Malang Singosari, Jl Raya Singosari No. 93, Lsari Kec. Singosari, Malang, Jawa Timur 65153
Account : 368-3040700
Swift Code : CENAIIDJA
/ IBAN

Prima Husada Sukorejo Hospital

On behalf : PT Disa Prima Medika
of
Bank : PT Bank Mandiri Persero Tbk
Branch : KK Malang Sutoyo, Jl. Letjen Sutoyo No. 18-20, Bunulrejo, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 35141
Account : 144-0055533324
Swift Code : BMRIIDJA
/ IBAN

-
7. If an action/examination is required for a Patient outside the Hospital, on the written recommendation of the FIRST PARTY and with the written approval of the SECOND PARTY, the bill will be charged to the SECOND PARTY.

PASAL 8 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Jangka waktu kerjasama pelayanan rujukan pasien dan pemeriksaan penunjang berlaku sejak ditandatangani, dan akan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan jika tidak ada pemberitahuan perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis.
2. Pada saat perjanjian kerjasama ini selesai tetapi masih terdapat pasien yang masih dalam perawatan atau pengobatan berdasarkan alasan-alasan medis yang ditentukan oleh dokter yang merawat harus tetap mendapat perawatan, pengobatan, dan atau melanjutkan layanannya. Tetap akan mendapatkan haknya sampai sembuh dan akan diklasifikasikan sebagai kasus khusus yang tidak dapat terpengaruh dengan pemutusan perjanjian kerjasama.

PASAL 9 KEADAAN MEMAKSA

1. Para Pihak sepakat apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi Keadaan Memaksa, maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa akan memberitahukan secara tertulis mengenai keadaan tersebut kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya peristiwa Keadaan Memaksa.
2. Terhadap kejadian Keadaan Memaksa tersebut dan segala akibatnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dimusyawarahkan bersama oleh Para Pihak untuk mencari cara mengatasinya dan agar setiap hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini dapat dipenuhi.
3. Apabila terjadi keadaan Keadaan Memaksa seperti tersebut di ayat (3) Pasal Perjanjian ini dan akibat-akibatnya tidak dapat diperbaiki dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Keadaan Memaksa tersebut terjadi serta tidak memungkinkan bagi Para Pihak untuk melanjutkan Perjanjian ini, maka Para Pihak dapat memilih mengakhiri Perjanjian ini melalui kesepakatan tertulis.

PASAL 10 HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini tunduk pada dan oleh karenanya wajib ditafsirkan serta dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.

ARTICLE 8 DURATION OF THE AGREEMENT

1. The term of cooperation for referral services and supporting examinations is signed, and will be valid for a period of 3 (three) years, and if there is no notification this agreement will be automatically extended.
2. At the time this cooperation agreement is completed but there are still patients who are still under treatment or treatment based on medical reasons determined by the treating doctor, they must continue to receive care, treatment, and or continue their services. They will still get their rights until they are cured and will be classified as special cases that cannot be affected by the termination of the cooperation agreement.

ARTICLE 9 FORCED MAJEURE

1. The Parties agree that if in the implementation of this Agreement a Forced Majeure occurs, the Party experiencing a Coercive Condition will notify the other Party in writing of the said situation no later than 7 (seven) calendar days after the Coercive Circumstances event occurs.
2. The occurrence of the Forced Majeure and all its consequences in connection with the implementation of this Agreement will be discussed jointly by the Parties to find ways to overcome them and so that each of the rights and obligations of the Parties under this Agreement can be fulfilled.
3. In the event of a Force Majeure as referred to in paragraph (3) of this Article of Agreement and its consequences cannot be remedied within 1 (one) month since the Forced Majeure occurred and it is not possible for the Parties to continue this Agreement, then the Parties may choose terminate this Agreement by written agreement.

ARTICLE 10 APPLICABLE LAW AND DISPUTE SETTLEMENT

1. This agreement is subject to and therefore must be interpreted and implemented based on the provisions of the laws and regulations in force in the territory of the Republic of Indonesia.

2. Seluruh perselisihan yang muncul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini wajib diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah dan itikad baik. Apabila ternyata secara musyawarah Para Pihak tidak mencapai suatu kesepakatan, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui pengadilan.
3. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya, Para Pihak setuju untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Negeri Malang

PASAL 11 KORESPONDENSI

Untuk setiap kegiatan korespondensi yang berhubungan dengan perjanjian ini ditujukan melalui :

Pihak Pertama : PT. Disa Prima Medika

Alamat : PERUM BANJARARUM SELATAN 3 B
RT 003 RW 012 BANJARARUM
SINGOSARI KABUPATEN MALANG

No Telp : 0341-458679

No. Fax : -

Bagian	Person In Charge (PIC)
Humas dan Marketing	RS Prima Husada Malang Nama : Nurlailatul farida Jabatan : Humas dan Marketing RS Prima Husada Malang no tlp : 0341-458679 ext 134 / 0811 3507 164 Email : marketing@malang.rs-primahusada.com RS Prima Husada Sukorejo Nama : Fefi rita indah hati Telp : 0343-6745000/081315574065,081357335016 Email : marketing@sukorejo.rs-primahusada.com
Finance (Claim)	RS Prima Husada Malang Nama : Novi Ratnasari, SE Jabatan : Administrasi Keuangan & Penagihan Telp : 0341-458679 ext 134 / 085855151810 Email : keuangan@malang.rs-primahusada.com RS Prima Husada Sukorejo Nama : Prisma Sandy Faradilla, S.ST Telp : 081315574065 / 0343 6745 000 ex 133 Email : keuangan@sukorejo.rs-primahusada.com
Patient Service Manager	RS Prima Husada Malang Nama : Daning, Amd.Keb Telp : (0341) 458679 ext 154 / 081131103113 Email : rs-primahusada@gmail.com RS Prima Husada Sukorejo Nama : Nuraini izah, S.Kep Telp : 08113031885 Email : rsprimahusadasukorejo@gmail.com
Pelayanan Penunjang Laboratorium / Radiologi	RS Prima Husada Malang Nama : Mada Amd.AK Telp : 0341-45879 ext 104 / 081259768168 Email : rs-primahusada@gmail.com RS Prima Husada Malang Nama : Elza Safarina Ulfa, Amd.AK Telp : 0343-6745 000 ext 132 Email : Penunjangrsphsukorejo@gmail.com

Alamat Korespondensi PIHAK KEDUA adalah:

2. All disputes arising out of or in connection with this Agreement must be resolved by the Parties by deliberation and good faith. If it turns out that by deliberation the Parties do not reach an agreement, then the dispute will be resolved through the courts.
3. Regarding this Agreement and all its consequences and implementation, the Parties agree to choose a general legal domicile and remain at the Registrar's Office of the Malang District Court.

ARTICLE 11 CORRESPONDENCE

For each correspondence activity related to this agreement, it is addressed through:

First Party : PT. Disa Prima Medika

Address : PERUM BANJARARUM SELATAN 3 B RT
003 RW 012 BANJARARUM
SINGOSARI KABUPATEN MALANG

No Telp : 0341-458679

No. Fax : -

Division	Person In Charge (PIC)
Public Relations and Marketing	RS Prima Husada Malang Nama : Nurlailatul farida Jabatan : Humas dan Marketing RS Prima Husada Malang no tlp : 0341-458679 ext 134 / 0811 3507 164 Email : marketing@malang.rs-primahusada.com RS Prima Husada Sukorejo Nama : Fefi rita indah hati Telp : 0343-6745000/081315574065,081357335016 Email : marketing@sukorejo.rs-primahusada.com
Finance (Claim)	RS Prima Husada Malang Nama : Novi Ratnasari, SE Jabatan : Administrasi Keuangan & Penagihan Telp : 0341-458679 ext 134 / 085855151810 Email : keuangan@malang.rs-primahusada.com RS Prima Husada Sukorejo Nama : Prisma Sandy Faradilla, S.ST Telp : 081315574065 / 0343 6745 000 ex 133 Email : keuangan@sukorejo.rs-primahusada.com
Patient Service Manager	RS Prima Husada Malang Nama : Daning, Amd.Keb Telp : (0341) 458679 ext 154 / 081131103113 Email : rs-primahusada@gmail.com RS Prima Husada Sukorejo Nama : Nuraini izah, S.Kep Telp : 08113031885 Email : rsprimahusadasukorejo@gmail.com
Pelayanan Penunjang Laboratorium / Radiologi	RS Prima Husada Malang Nama : Mada, Amd.AK Telp : 0341-45879 ext 104 / 081259768168 Email : rs-primahusada@gmail.com RS Prima Husada Malang Nama : Elza Safarina Ulfa, Amd.AK Telp : 0343-6745 000 ext 132 Email : Penunjangrsphsukorejo@gmail.com

The SECOND PARTY Correspondence Address is:

PT. Yamindo (Yanmar Agricultural Machinery
Manufacturing Indonesia)
Kontak Person
Telepon:
Fax
a. Harmanico Prasetyo, SH.
Phone : 0812 1661 4444
Email : harmanico_prasetyo@yanmarcom
b. Holis Safana
Phone: 0856 4663 6463
Email: holis_safana@yanmar-yamindo.co.id
c. Viera Mashita Dewi
Phone: 0823 321 2 3481
Email : viera_shita@yanmar-yamindo.co.id

PASAL 12 KERAHASIAAN

1. Para Pihak setuju bahwa setiap Informasi Rahasia, termasuk namun tidak terbatas pada data, identitas dan resume medis Pasien yang diberikan selama masa berlakunya Perjanjian ini harus diperlakukan secara sangat rahasia sebagaimana diatur dalam peraturan tentang rahasia kedokteran dan tidak boleh diperdagangkan, dipublikasikan ataupun diberitahukan kepada pihak manapun dengan cara apapun, termasuk di dalamnya membuat fotokopi atau reproduksi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang memberikan. Pihak yang menerima harus menggunakan cara yang sama untuk melindungi kerahasiaan informasi tersebut sebagaimana halnya Pihak tersebut melindungi hal-hal miliknya sendiri yang bersifat rahasia.
2. Informasi Rahasia tidak dapat digunakan untuk tujuan apapun selain daripada ditentukan oleh Perjanjian ini atau diungkapkan oleh salah satu Pihak kepada pihak ketiga lainnya, kecuali telah mendapatkan persetujuan dari salah satu Pihak.
3. Ketentuan tentang Kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Pasal ini tetap berlaku bagi Para Pihak walaupun jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir.

PASAL 13 KETERPISAHAN

Apabila ada ketentuan dari Perjanjian ini yang menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini tetap berlaku. Namun demikian, Para Pihak akan sesegera mungkin mengganti ketentuan tersebut dengan ketentuan baru yang sedapat mungkin mempunyai penafsiran yang paling dekat dengannya.

PASAL 14 PENGALIHAN

Masing-masing Pihak tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga di luar Perjanjian ini

PT. Yamindo (Yanmar Agricultural Machinery
Manufacturing Indonesia)
Personnel Section
Phone: 0343- 631361
Fax: 0343-631363
a. Harmanico Prasetyo, SH.
Phone : 0812 1661 4444
Email : harmanico_prasetyo@yanmarcom
b. Holis Safana
Phone: 0856 4663 6463
Email : holis_safana@yanmar-yamindo.co.id
c. Viera Mashita Dewi
Phone: 0823 321 2 3481
Email : viera_shita@yanmar-yamindo.co.id

ARTICLE 12 CONFIDENTIALITY

1. The Parties agree that any Confidential information, including but not limited to Patient data, identity and medical resume provided during the validity period of this Agreement must be treated strictly confidentially as regulated in the regulations on medical secrets and may not be traded, published or disclosed to any party. in any way, including making photocopies or reproductions, without the prior written consent of the party providing. The receiving party must use the same means to protect the confidentiality of the information as the party protecting its own confidential matters.
2. Confidential Information may not be used for any purpose other than those specified by this Agreement or disclosed by either Party to another third party, unless it has obtained the approval of one of the Parties.
3. The provisions regarding Confidentiality as regulated in this Article will still apply to the Parties even though the term of this Agreement has ended.

ARTICLE 13 SEPARATION

If any provision of this Agreement becomes invalid, invalid or unenforceable, the other provisions of this Agreement will remain in effect. However, the Parties will as soon as possible replace the provision with a new provision which as far as possible has the closest interpretation to it.

ARTICLE 14 TRANSFER

Neither Party may transfer part or all of its rights and obligations under this Agreement to a third party outside this Agreement without obtaining the prior written consent of the other Party.

tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lain.

PASAL 15
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan dituangkan lebih lanjut dalam addendum yang ditandatangani dan disetujui oleh Para Pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini mengandung seluruh pengertian antara Para Pihak dan menggantikan semua perundingan, surat-menyurat, Perjanjian sebelumnya, dan kesepakatan verbal / non verbal lain apapun yang dilakukan sebelumnya antara Para Pihak, baik secara lisan atau tulisan berkenaan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini ditandatangani secara patut oleh Para Pihak pada tanggal sebagaimana tersebut di awal Perjanjian, dibuat dalam dua (2) rangkap, masing-masing asli, telah dibubuhi materai secukupnya serta memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pasuruan, Maret 02 2024
PIHAK PERTAMA
PT DISA PRIMA MEDIKA

ENDANG SUSILOWATI
DIREKTUR UTAMA

ARTICLE 15
CLOSING

1. Matters that have not been regulated or sufficiently regulated in this Agreement, will be further stated in an addendum which is signed and approved by the Parties and constitutes an integral part of the Agreement.
2. This Agreement contains the entire understanding between the Parties and supersedes all negotiations, correspondence, previous agreements, and any other verbal/non-verbal agreements previously made between the Parties, either verbally or in writing with respect to matters stipulated in this Agreement.

Thus this Agreement is properly signed by the Parties on the date as stated at the beginning of the Agreement, made in two (2) copies, each original, has been affixed with sufficient stamp duty and has the same legal force.

PIHAK KEDUA
PT YANMAR DIESEL INDONESIA

...
PIMPINANSS